UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

FisioEduca Rural

Autores: Kevin Lopez Cordoba · Jorge Enrique Agredo Bravo · Joseph Tello Ramos · Kevin Stiben Caicedo Gomez

Docente: Catalina Jiménez Cerquera
Administración y Gestión en Fisioterapia · Grupo C · Equipo 12

Introducción

Las comunidades rurales y de difícil acceso presentan barreras geográficas, económicas y educativas que limitan el acceso a información sobre actividad física y autocuidado. Esta situación afecta especialmente a adultos de 30 a 59 años, quienes pueden presentar hábitos sedentarios, desconocimiento de prácticas preventivas y creencias como considerar que el trabajo del campo es suficiente actividad física. Las entrevistas realizadas permitieron reconocer estas necesidades y dificultades. Frente a esta problemática, FisioEduca Rural propone un servicio de promoción de la salud desde fisioterapia que integra educación presencial, materiales ilustrados y herramientas digitales complementarias, adaptándose a las condiciones de conectividad y aprendizaje de la población.

Justificación y vinculación con los ODS

FisioEduca Rural surge de la necesidad de acercar la educación en salud a comunidades rurales, facilitando el aprendizaje de prácticas de actividad física y autocuidado mediante estrategias accesibles y participativas. Su propuesta combina talleres presenciales, fichas ilustradas, audios descargables y herramientas digitales, disminuyendo la dependencia de internet y favoreciendo la participación comunitaria. El proyecto se vincula con tres Objetivos de Desarrollo Sostenible: - ODS 3. Salud y bienestar (meta 3.4): promueve hábitos saludables y conocimientos orientados a la prevención de enfermedades no transmisibles. - ODS 4. Educación de calidad (meta 4.7): fomenta conocimientos y habilidades para adoptar estilos de vida saludables y sostenibles. - ODS 10.

Objetivos

Objetivo general Diseñar un prototipo de servicio educativo desde fisioterapia promoviendo la actividad física y el autocuidado en adultos de 30 a 59 años de comunidades rurales y de difícil acceso. Objetivos específicos 1. Identificar las necesidades y barreras relacionadas con la actividad física y el autocuidado mediante entrevistas y análisis de tendencias. 2. Diseñar un prototipo de servicio educativo que integre estrategias presenciales y recursos físicos y digitales adaptados a la población. 3. Evaluar la percepción de utilidad, comprensión y accesibilidad del prototipo mediante pruebas con usuarios objetivo. 4. Identificar oportunidades de mejora a partir de la retroalimentación obtenida para fortalecer el diseño del servicio.

Descripción del prototipo y metodología

FisioEduca Rural es un prototipo de servicio de promoción de la salud desde fisioterapia, dirigido a adultos de 30 a 59 años de comunidades rurales y de difícil acceso. Integra talleres presenciales, fichas ilustradas, audios descargables, códigos QR y WhatsApp como recursos complementarios, permitiendo acceder a la educación en salud con o sin conexión a internet. Su funcionamiento se organiza en tres momentos: - Antes: acercamiento a la comunidad y convocatoria mediante líderes, carteles y WhatsApp. Metodología: se identificó el problema mediante un árbol de problemas y los cinco porqués; posteriormente, se realizaron entrevistas, análisis de tendencias y construcción de perfiles de usuarios. Con esta información se diseñó el prototipo y se realizaron dos pruebas con usuarios objetivo. Estas mejoras están pendientes de una nueva validación

Impacto y actores estratégicos

FisioEduca Rural espera favorecer el conocimiento sobre movimiento, actividad física y autocuidado en adultos de 30 a 59 años de comunidades rurales y de difícil acceso. Su impacto esperado comprende tres dimensiones: en la función corporal, fortalecer el conocimiento sobre el cuidado del cuerpo; en la actividad y participación, facilitar la práctica de ejercicios sencillos y la participación en encuentros educativos; y en los factores ambientales, disminuir barreras de acceso mediante materiales ilustrados, espacios comunitarios conocidos y recursos que no dependan exclusivamente de internet. Los actores estratégicos son los adultos participantes, estudiantes y profesionales de fisioterapia, líderes comunitarios, Juntas de Acción Comunal, docentes, escuelas y puestos de salud.

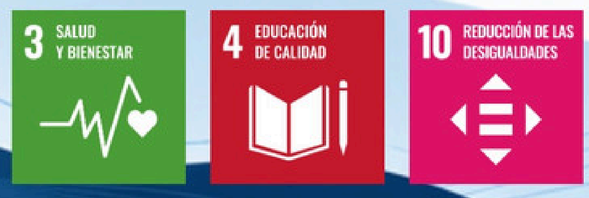
Conclusión

FisioEduca Rural combinó recursos presenciales y digitales de educación en salud. Dos pruebas iniciales orientaron materiales más comprensibles. Falta desarrollar un taller piloto comunitario y evaluar su accesibilidad y continuidad.



Abrir prototipo

ODS del proyecto



Referencias bibliográficas